

Université de Constantine

2024

Faculté de médecine

3^{ème} année de médecine

Module de sémiologie de l'appareil génital féminin

Pr : K. MESGHOUNI

L'examen clinique en gynécologie

OBJECTIFS

- Exercer un examen physique de l'appareil génital féminin
- Apprécier les caractères sexuels secondaires
- Décrire l'aspect du col au spéculum
- Décrire la technique d'un touché vaginal

PLAN

1. Les conditions de l'examen :
2. Conduite de l'examen :
 - a. L'inspection
 - b. L'examen de l'abdomen
 - c. L'examen au spéculum:
 - d. Le toucher vaginal

1. Les conditions de l'examen :

La malade doit être examinée : soit sur une table gynécologique, soit sur une table d'examen ; en décubitus dorsal, les cuisses à demi fléchies, en abduction, les jambes fléchies.

Il est indispensable que la malade vide préalablement sa vessie et son rectum.

Le matériel nécessaire est le suivant : un spéculum et un doigtier à deux doigts stérile, un produit lubrifiant.

.2. Conduite de l'examen :

a. L'inspection :

Va apprécier les caractères sexuels secondaires :

- ✓ les seins,
- ✓ la pilosité axillaire, la pilosité pubienne qui est triangulaire
- ✓ et les organes génitaux externes :
 - les grandes lèvres sont normalement charnues,
 - les petites lèvres sont pigmentées et humides.

b. L'examen de l'abdomen :

La palpation

Permet de rechercher l'existence de zones douloureuses dans les fosses iliaques ou la région sus-pubienne; peut révéler l'existence d'une tumeur abdomino-pelvienne.

La percussion

Est utile dans les tumeurs abdomino-pelviennes, elle permet de différencier un volumineux kyste de l'ovaire à développement abdominal d'une ascite.

c. L'examen au spéculum : Mise en place du speculum :

- Préalablement lubrifié de sérum physiologique (jamais d'antiseptiques ni de corps gras), le spéculum est introduit de façon atraumatique.
- Les bords des lames fermées prennent appui sur la fourchette vulvaire après ouverture de la vulve par écartement des petites lèvres.
- Les valves sont donc placées verticalement dans l'axe de la fente vulvaire. Puis en poussant le spéculum, on fait une rotation de 90° sur l'horizontal en visant une direction à 45° du plan de la table vers la pointe du sacrum.
- Arrivé au contact du col, le spéculum est ouvert, le col doit être bien visible. Si le col n'est pas vu, il faut prendre un spéculum plus long.
- L'examen au spéculum doit souvent être précédé d'un nettoyage à la compresse sèche (au bout d'une pince) des sécrétions vaginales.

Il permet d'apprécier l'aspect du col de l'utérus.

- Sa situation : centrale ou déviée latéralement.
- Sa forme : conique chez la nullipare, cylindrique chez la multipare, atrophique chez la femme ménopausée.
- Son orifice externe : recherche de lésion traumatique à type de déchirure, d'érosions : qui sont le signe d'une exocervicite, d'ulcérations ou tumeur proliférante.

Il permet également d'effectuer *des frottis vaginaux* qui consiste à étaler sur une lame les cellules desquamées du col et du vagin et à les examiner au microscope ; il permet de pratiquer *une colposcopie* qui est l'examen du col à la loupe binoculaire Enfin, il permet d'effectuer *des biopsies du col* sous contrôle de la vue lorsqu'il existe des lésions suspectes.

d. Le toucher vaginal :

Se fait avec le doigtier stérile à deux doigts en utilisant un produit lubrifiant (vaseline), l'index et le majeur sont introduits dans le vagin et vont apprécier :

1/ L'état du col utérin : sa situation, sa consistance : normalement souple; ferme et élastique comparable au cartilage nasal; chez la femme enceinte, il est mou.

2/ L'état des culs-de-sac vaginaux : culs-de-sac latéraux et postérieur : leur souplesse et leur vacuité.

3/ Le toucher vaginal combiné au palper abdominal

-Permet d'apprécier l'utérus : son siège, sa forme, son volume, sa consistance et sa sensibilité

-D'explorer les annexes : les ovaires normaux ne sont habituellement pas perçus sauf chez la femme maigre : ils sont retrouvés dans les culs-de-sac latéraux, ils ont la taille d'une amande et sont de consistance élastique.

4/ Le toucher vaginal associé au toucher rectal

-Permet d'apprécier l'état de la cloison recto vaginale.

-Enfin, on n'omettra pas de noter l'aspect du doigtier : normalement propre ou au contraire souillé de sang ou de leucorrhées.

-Chez la jeune fille (VIERGE), le toucher vaginal sera remplacé par le toucher rectal.

Bibliographie

1. Rose marie Hamladji. *Précis de Sémiologie, sémiologie de l'appareil génital*, pp 311-317
2. Baptiste Coustet. *Sémiologie médicale*, point important de l'anamnèse, PP363-4
3. Université Pierre et Marie Curie Gynécologie Niveau DCEM2 ; PP17- 1